Resumos de Pediatria



Batistaz

Revisão Flash · Emergência

Choque e Sepse na Criança

Da suspeita à primeira hora

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Choque e sepse na criança

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Reconhecer a má perfusão antes da hipotensão; na primeira hora, lactato, cultura sem atrasar, antibiótico, bolus de cristaloide reavaliando a cada um e vasoativo periférico se a perfusão não voltar; na anafilaxia, adrenalina IM primeiro.

1. **Choque:** enchimento lento, extremidade fria, taquicardia, consciência alterada. PA cai por último.
2. **Phoenix:** sepse = infecção + escore ≥ 2; choque séptico = sepse + ≥ 1 ponto cardiovascular. Não é triagem.
3. **Antibiótico:** até 1 h no choque séptico; até 3 h na sepse provável sem choque.
4. **Fluido:** balanceado, 10–20 mL/kg por bolus, até 40–60 mL/kg/1ª h com UTI. Sem UTI e sem hipotensão: sem bolus.
5. **Parar o bolus:** crepitações, hepatomegalia nova ou crescente, choque resolvido.
6. **Droga:** adrenalina ou noradrenalina, periférica se preciso; vasopressina se dose alta.
7. **Não fazer:** hidrocortisona de rotina, etomidato, albumina como 1ª escolha.
8. **Anafilaxia:** adrenalina IM 0,01 mg/kg (máx. 0,3 mg) na coxa, repetir 5–15 min; observar 6–8 h a 24–48 h.

Doses de bolso

Item	Dose
Bolus (SSC)	10–20 mL/kg
Bolus (NICE)	10 mL/kg em < 10 min
Adrenalina (infusão)	0,05–0,3 µg/kg/min
Ceftriaxona pré-referência	100 mg/kg IM, máx. 2 g

Pegadinha

O2 88–92% é alvo depois de estabilizar, não na chegada da criança em choque.

Checklist antes do plantão

- ☐ Reconheço choque compensado
- ☐ Uso o semáforo na criança febril
- ☐ Sei calcular o Phoenix
- ☐ Sei os dois relógios do antibiótico
- ☐ Prescrevo bolus e reavalio
- ☐ Reconheço sobrecarga de volume
- ☐ Inicio vasoativo periférico
- ☐ Sei a dose de adrenalina IM
- ☐ Faço manutenção isotônica